EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93122
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-19 14:05:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: WALTER VALENTIN SANCHEZ GOMEZ			RUN	: 8.199.749-7
F.Nac	: 12-04-1963	Edad	: 61 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: MONTELEON			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-14	Fecha Egreso	: 2024-09-19 14:05:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NAC en tratamiento
EPOC
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Usuario de 61 años con antecedentes de EPOC, HTA, en tto crónico con amlodipino 5 mg cada 12 horas vo , enalapril 10 mg cada 12hotras vo , salmetrol 2 puff cada 12 horas , bromuro 2 puff cada 12 horas, Sertralina 50 mg 3 comprimidos al dia, clonazepam 2mg 1por noche, melatonina 2 al dia. sin alergias conocidas. Consulta en la UE traído por ambulancia de aps San Nicolás desde domicilio por presentar desde las 00 am disnea, desaturación de hasta 65%, cianosis peribucal. refiere que desde el Lunes 09/09/24 se encuentra con cursando con cuadro respiratorio, CEG, tos productiva. Ingresa a UE en glasgow 15 pts, al CSV normocardico, hipertenso sistolico, normosaturando con apoyo de O2 por naricera 3 litros. Se pasa a box toman exámenes incluidos GSA con fio2 al 28%, se administra tto broncodilatador indicado. Al exámen físico piel rosada, tibia al tacto, llene capilar <2 segundos, yugulares planas, leve disnea, sin uso de musculatura accesoria, abdomen BDI, moviliza 4 extremidades, sin edema.
TAC TORAX Impresión: Prominentes bronquiectasias quísticas bilaterales acompañadas de signos de enfermedad de la vía aérea. -Bronquiolitis celular bilateral y tenues opacidades en vidrio esmerilado bilaterales, de probable etiología inflamatoria - infecciosa. -Moderado enfisema pulmonar. -Ateromatosis aórtica.
Con buen respuesta tto broncodilatador con requerimientos de oxigeno suplementario, 24% por naricera, se reduce de manera gradual hasta fio2 ambiental con desaturacion que llega a 85%. por lo que se decide hospitalizar
Durante estancia con requeimiento en disminucion de O2 suplementario, actualmente desde hace 48 hrs sin apoyo con O2 suplementario, saturando 90-92% ambiental, con menor disnea
Actualmente cursando su dia N° 6 hospitalizado, dia N° 6 de ceftriaxona en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: estable, sin conflicto actual
3) Respiratorio/infeccioso: Con parametros inflamatorios en descenso, se completaran 10 dias de terapia ATB, sumado a KNT rehabilitadora y control con examenes de lab 23/09

INDICACIONES AL ALTA

1. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 4 dias
2. Salbutamol 2 puff c/6hrs por AC por 7 dias
3. Bromuro de ipratropio 2 puff c/6hrs por AC por 7 dias
4. AMlodipino 10 mg, medio comp al dia VO por 4 dias
5. Sertralina 50 mg al dia VO por 4 dias
6. Prednisona 20 mg al dia VO por 4 dias
7. Enalapril 10 mg c/12 hrs VO por 4 dias
8. Examenes de control 23/09
9. KNT respiratoria una vez al dia

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO